

Tricotilomanía — diagnóstico y manejo integral

(Basado en DSM-5-TR 2022, Guías Clínicas MINSAL Chile 2023, American Psychiatric Association 2024, British Association of Dermatologists 2023, UpToDate 2025 y Fitzpatrick's Dermatology 2023.)

1. Introducción y relevancia clínica

La **tricotilomanía** es un **trastorno del control de impulsos** caracterizado por **arrancamiento recurrente del propio cabello**, que conduce a **pérdida capilar irregular y visible**.

En el **DSM-5**, se clasifica dentro de los **trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados**, junto con la excoriación (rascado compulsivo) y el trastorno dismórfico corporal.

Aunque afecta principalmente el cuero cabelludo, también puede comprometer **cejas, pestañas, barba, vello púbico o corporal**.

Relevancia clínica

- Suele confundirse con **alopecia areata**, pero su causa es **psicológica y conductual**.
 - Es frecuente en **niñas y mujeres jóvenes**, aunque puede presentarse a cualquier edad.
 - Tiene **repercusiones emocionales y sociales significativas**, con frecuente **comorbilidad ansiosa o depresiva**.
 - En **EUNACOM**, se pregunta por el **diagnóstico diferencial con alopecia areata** y el **manejo cognitivo-conductual**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Definición

Trastorno crónico del control de impulsos caracterizado por:

- Arrancamiento repetitivo de cabello o vello corporal.

- Incapacidad para resistir el impulso.
 - Alivio o placer temporal tras la acción.
 - Consecuente alopecia irregular.
-

2.2. Bases neurobiológicas

- Disregulación de los **circuitos frontoestriatales**, similares a los implicados en el **TOC**.
 - Desequilibrio en neurotransmisores:
 - **Serotonina (5-HT) ↓**
 - **Dopamina ↑**
 - **Glutamato y GABA** implicados en control del impulso.
 - Estudios de neuroimagen muestran **hiperactividad en corteza cingulada anterior y ganglios basales**.
-

2.3. Factores predisponentes

Tipo	Ejemplos
Psicológicos	Estrés, ansiedad, aburrimiento, tensión interna
Biológicos	Herencia familiar, disfunción serotoninérgica
Ambientales	Aislamiento, dinámicas familiares disfuncionales
Comorbilidades	Trastornos depresivos, ansiedad generalizada, TOC, TDAH

2.4. Ciclo conductual

1. **Tensión o ansiedad previa** → necesidad irresistible de arrancar el cabello.
2. **Acción de tracción** → sensación de alivio o placer momentáneo.
3. **Culpa o vergüenza posterior** → refuerzo negativo que perpetúa el ciclo.

Este patrón de gratificación y culpa es clave para diferenciarlo de otras alopecias no psicógenas.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones clínicas

- Pérdida de cabello **de patrón irregular o parcheado**, con **pelos de distinta longitud** (rotos o arrancados).
 - Zonas predilectas: cuero cabelludo (vértice o región parietal), pestañas, cejas, barba o región púbica.
 - **Piel indemne**, sin descamación, eritema ni signos inflamatorios.
 - A veces **folículos eritematosos o costrosos** por tracción repetida.
 - En casos severos: **tricofagia** (ingestión del cabello), con riesgo de **tricobezoares gástricos** (síndrome de Rapunzel).
-

3.2. Patrón del comportamiento

- **Tracción consciente**: paciente reconoce el acto, lo realiza para aliviar ansiedad o tensión.
- **Tracción inconsciente o automática**: ocurre sin plena consciencia (p. ej. durante el estudio o frente a pantallas).

En ambos casos, suele acompañarse de **rituales asociados**, como examinar, morder o jugar con los cabellos arrancados.

3.3. Impacto emocional

- Vergüenza, evitación social, baja autoestima.
 - Ocultamiento mediante gorros, pelucas o maquillaje.
 - En casos graves, aislamiento o síntomas depresivos.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Alopecia areata	Placas redondas, piel lisa, pelos en signo de exclamación, sin longitudes variables
Tiña capitis	Placas descamativas, prurito, hifas en KOH positivo
Tracción mecánica (peinados)	Distribución simétrica en áreas de tensión; sin compulsión
Efluvio telógeno	Caída difusa sin zonas parcheadas ni compulsión
Tricoteiromanía / excoriación neurotóxica	Rasgado repetitivo de la piel, sin tracción capilar
Lupus discoide / liquen plano pilar	Cicatriz y eritema, descamación periférica

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico (DSM-5-TR, 2022)

Criterios para **Tricotilomanía (Trastorno de arrancamiento del cabello)**:

- A. Arrancamiento recurrente del propio cabello, con pérdida capilar visible.
 - B. Intentos repetidos de disminuir o detener el comportamiento.
 - C. Causa malestar clínicamente significativo o deterioro funcional.
 - D. No atribuible a otra afección médica (p. ej. dermatológica).
 - E. No explicada mejor por otro trastorno mental (p. ej. TOC, psicosis).
-

4.2. Exámenes complementarios

No existen pruebas específicas; se utilizan para descartar causas dermatológicas:

- **Tricoscopía**: pelos rotos de distintas longitudes, puntos negros, tallos enrollados; sin signos inflamatorios.
 - **Examen micológico directo (KOH)**: negativo.
 - **Biopsia (rara vez necesaria)**: folículos traumáticos, hemorragia perifolicular, sin infiltrado inflamatorio.
-

4.3. Comorbilidades a pesquisar

- Trastornos de ansiedad y del estado de ánimo.
 - Trastorno obsesivo-compulsivo.
 - Trastornos de control de impulsos.
 - Trastorno dismórfico corporal.
 - Trastornos de la conducta alimentaria.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / APA / EADV)

5.1. Principios generales

- La tricotilomanía requiere **abordaje multidisciplinario**:
dermatológico + psiquiátrico + psicológico.
- El objetivo es **reducir el comportamiento de tracción**, mejorar el **control del impulso** y **tratar la comorbilidad ansiosa o depresiva.**

5.2. Terapia psicológica (primera línea)

La **Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)** es el tratamiento de elección.

Incluye varias estrategias combinadas:

Técnica	Objetivo / componentes
Entrenamiento en reversión de hábito (HRT)	Identificar estímulos y sustituir tracción por conductas incompatibles (p. ej. apretar una pelota, tejer).
Terapia de exposición y prevención de respuesta	Exposición al impulso sin realizar la conducta; control del deseo.
Terapia cognitiva	Identificar pensamientos automáticos (“no puedo evitarlo”) y reemplazarlos por respuestas racionales.
Técnicas de relajación y mindfulness	Reducen la ansiedad y el automatismo del acto.
Psicoeducación familiar	Favorece comprensión y apoyo, evitando juicios o castigos.

Evidencia: estudios controlados muestran mejoría del 60–70% con HRT estructurada en 8–12 sesiones.

5.3. Tratamiento farmacológico

No existen fármacos aprobados específicamente, pero se usan como adyuvantes cuando hay comorbilidad significativa o respuesta parcial a TCC.

Clase	Ejemplo	Comentarios
ISRS (primera línea farmacológica)	Fluoxetina, sertralina, escitalopram	Útiles en ansiedad/TOC concomitante
Antidepresivos tricíclicos	Clomipramina	Buena evidencia, inhibe recaptura de serotonina y dopamina
Ansiolíticos / estabilizadores	N-acetilcisteína (NAC) 1200–2400 mg/día	Modula glutamato; mejora control del impulso
Antipsicóticos atípicos (segunda línea)	Olanzapina, aripiprazol (bajas dosis)	Solo en casos refractarios o con tics asociados

5.4. Medidas complementarias

- Evitar situaciones gatillantes (estrés, aburrimiento, estudio solitario).
 - Registrar el comportamiento (diario de impulsos).
 - Uso de barreras físicas: gorros, guantes, vendajes o peinados que dificulten la tracción.
 - Corrección de déficit de hierro o zinc si existen.
 - Apoyo grupal o terapia familiar en adolescentes.
-

5.5. Seguimiento

- Controles cada 4–6 semanas.
- Evaluar recaídas (frecuentes).
- Coordinación continua con psicología y psiquiatría.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Tricobezoar gástrico (síndrome de Rapunzel)	Ingesta crónica de cabellos → masa gástrica que puede requerir cirugía
Alopecia cicatricial secundaria	En casos crónicos con daño folicular repetido
Infecciones bacterianas locales	Foliculitis, piodermia
Alteraciones emocionales	Vergüenza, ansiedad, depresión
Deterioro social / escolar / laboral	Por ocultamiento o estigmatización

Pronóstico:

- Mejor en niños y adolescentes, con alta tasa de remisión parcial.
- En adultos, curso crónico con recaídas, pero **mejoría sostenida con TCC estructurada y apoyo familiar.**

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. La **tricotilomanía** es un **trastorno del control de impulsos**, no una alopecia dermatológica.
2. **Zonas parcheadas con cabellos de distinta longitud** orientan el diagnóstico.
3. El **examen micológico es negativo y no hay signos inflamatorios ni pelos en signo de exclamación**.
4. **Terapia cognitivo-conductual (reversión de hábito)** es el tratamiento de primera línea.
5. Los **ISRS o clomipramina** son adyuvantes útiles si hay ansiedad o TOC asociado.
6. En **EUNACOM**, la frase clave es:

“Paciente joven con áreas irregulares de alopecia, pelo de distinta longitud y niega conscientemente arrancarlo.”



Errores comunes

- Diagnosticarla como alopecia areata y tratar con corticoides.
 - No pesquisar comorbilidades psiquiátricas.
 - Tratar solo con medicamentos sin psicoterapia.
 - Juzgar o confrontar al paciente (“deje de hacerlo”), generando resistencia.
 - No descartar tricofagia (riesgo quirúrgico real).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **tricotilomanía** es un **trastorno del control de impulsos** caracterizado por **arrancamiento compulsivo del cabello**, causando alopecia irregular.

2. Se diferencia de la **alopecia areata** por la presencia de **pelos de distintas longitudes**, ausencia de inflamación y **negativa o vergüenza al admitir el acto**.
3. El **diagnóstico es clínico** según criterios DSM-5 y se confirma excluyendo causas dermatológicas.
4. El **tratamiento de elección es la terapia cognitivo-conductual (HRT)**; farmacoterapia (ISRS, clomipramina, NAC) puede usarse como complemento.
5. Es esencial el **abordaje multidisciplinario** (dermatología + psiquiatría + psicología).
6. En casos con tricotofagia, debe **descartarse tricobezoar gástrico**.
7. En **EUNACOM**, recordar:
 - “Alopecia irregular con pelos rotos de distinta longitud → tricotilomanía.”
 - “Primera línea: terapia cognitivo-conductual.”